

RheumaCheck

Finaler QA-Durchgang V6

Inhaltliche Prüfung, Zielgruppenlogik, Abstimmungsreihenfolge und Layout-/Druckkontrolle

Stand: 11.05.2026 | Arbeitsstand für interne Abstimmung IMDB / salvevita / IKB

Statusurteil: Das V6.2-Gesamtpaket ist als interne Arbeits- und Diskussionsfassung geeignet. Es sollte vor externer breiter Ausspielung noch mit Robert Lange / salvevita und anschließend mit Michael Zänker / IKB klinisch und workflowbezogen abgestimmt werden.

1. Prüfgegenstand

Geprüft wurden die V6-Dokumente des RheumaCheck-Fragebogenpakets einschließlich der vier Module A-D und des konsolidierten Gesamtpakets V6.2. Ziel war nicht die inhaltliche Neuentwicklung, sondern ein QA-Durchgang mit Blick auf Vollständigkeit, Zielgruppenlogik, Dopplungen, Reihenfolge der Abstimmung sowie Druck- und Layouttauglichkeit.

Dokument	Zielgruppe	Funktion	Umfang	QA-Status
Bogen A V6.1	Patient:innen	Vorab-Anamnese und Stratifizierung	6 Seiten	vorhanden / V6-konform
Bogen B V6.1	Rheumanetzwerk / Ärzt:innen	Standardmethode und Versorgungspfad	8 Seiten	vorhanden / V6-konform
Bogen C V6.1	Patient:innen / Nutzer:innen	Usability, Ergebnisverständnis, Versorgungsnutzen nach Nutzung	6 Seiten	vorhanden / V6-konform
Bogen D V6.1	Ärzt:innen / Versorgung	Implementierbarkeit, erwarteter Nutzen, Evidenzanforderungen	6 Seiten	vorhanden / V6-konform
Gesamtpaket V6.2	Projektteam	Konsolidierte Gesamtfassung A-D	27 Seiten	vorhanden / QA-geprüft

2. Inhaltlicher QA-Befund

- Die Vier-Modul-Architektur ist fachlich plausibel und korrigiert die frühere V5.1-Logik: Die Umfrage zur Standardmethode gehört primär in den Rheumanetzwerk-/Ärztebereich und nicht nur in einen patientengerichteten Ist-Stand-Bogen.
- Bogen A und C sind patientengerichtet und klar voneinander getrennt: A vor Nutzung / vor Stratifizierung; C nach Nutzung / nach Test- oder Workflow-Erfahrung.
- Bogen B und D sind ärztlich bzw. versorgungsstrukturell ausgerichtet, haben aber unterschiedliche Funktionen: B erhebt den Status quo und den Versorgungspfad; D bewertet Implementierbarkeit, Nutzen, Evidenzanforderungen und Pilotbereitschaft.
- Die Abstimmungsreihenfolge ist konsistent: zunächst GrobAbstimmung mit Robert Lange / salvevita, danach klinische Feinabstimmung mit Michael Zänker / IKB, anschließend ggf. Abstimmung mit weiteren Rheumanetzwerk-Mitgliedern.
- Die bisherigen Module sind als professionelle Arbeits- und Diskussionsfassung geeignet, aber noch nicht als final validierte Studieninstrumente zu verstehen.

3. Prüfung der Zielgruppenlogik

Bogen	Primäre Zielgruppe	Zeitpunkt	Logik stimmig?
A	Patient:innen mit Gelenkbeschwerden oder RA-Verdacht	vor Test / vor digitaler Einordnung	Ja
B	Rheumanetzwerk, Ärzt:innen, Versorgungsakteure	vor / während Projektplanung zur Standardmethode	Ja
C	Patient:innen / Nutzer:innen nach Kontakt mit RheumaCheck-Prozess	nach Test, App-/CUBE-Demonstration oder Pilotnutzung	Ja
D	Ärzt:innen, Hausarzt-/Facharzt-/Klinik-/MVZ-Settings	vor Pilotierung und zur Implementierungsplanung	Ja

Bewertung: Die Zielgruppenlogik ist konsistent. Wichtig ist, Bogen B und D nicht unkommentiert an dieselbe Personengruppe gleichzeitig zu versenden. Für ein frühes Rheumanetzwerk-Gespräch kann Bogen B zuerst eingesetzt werden; Bogen D eignet sich als zweiter, stärker produkt- und implementierungsorientierter Bogen.

4. Dopplungs- und Abgrenzungsprüfung

Es gibt unvermeidbare thematische Berührungspunkte zwischen Bogen B und Bogen D, vor allem bei erwarteten Nutzenaspekten. Diese Dopplung ist methodisch vertretbar, solange die Funktion klar bleibt: Bogen B fragt den heutigen Standard und Versorgungspfad ab; Bogen D fragt nach der zukünftigen klinischen Einsetzbarkeit von RheumaCheck.

Empfehlung: Für die erste Abstimmung mit Robert und Frank sollten Bogen B und D getrennt vorgelegt werden. Falls die Befragung im Rheumanetzwerk zu lang wird, können Bogen B und D später zu einer gekürzten Kombiversion zusammengeführt werden.

5. Layout- und Druckprüfung

- Alle relevanten DOCX-Dateien wurden als PDF gerendert; die Seitenbilder wurden visuell geprüft.
- Die Tabellen bleiben innerhalb der Seitenränder. Kein erneutes Problem mit überbreiten Tabellen wurde im V6.2-Gesamtpaket festgestellt.
- Die Gesamtfassung ist mit 27 Seiten länger als eine reine Sitzungsunterlage; für Besprechungen sollte zusätzlich mit einer kompakten Kurzfassung oder Modulübersicht gearbeitet werden.
- Die Einzelbögen A-D sind besser druck- und besprechbar als das Gesamtpaket, wenn einzelne Zielgruppen oder Fachfragen diskutiert werden.

6. Fachliche und methodische Hinweise vor externer Nutzung

- Bogen A ersetzt keine klinische Diagnose und sollte als Vorab-Anamnese / Stratifizierungshilfe formuliert bleiben.
- Bogen C sollte im vollen Umfang erst eingesetzt werden, wenn ein realer oder zumindest simuliert demonstrierbarer RheumaCheck-Workflow vorliegt; sonst nur als Erwartungs-/Prototyp-Bewertung verwenden.
- Bei SUS-orientierten Items ist vor einer formalen Studie sicherzustellen, ob die Original-SUS-Skala korrekt und unverändert verwendet wird oder ob nur eine projektbezogene Usability-Erweiterung genutzt wird.
- Vor digitaler Umsetzung sind Datenschutz, Einwilligung, Zweckbindung und Export-/Auswertungslogik zu klären.
- Vor breiter Rheumanetzwerk-Befragung sollte mit Michael Zänker geklärt werden, welche klinischen Begriffe, Zeitachsen und Versorgungskategorien für die Zielgruppe am besten verständlich sind.

7. Entscheidungsvorschlag

QA-Empfehlung: V6.2 kann als fachlich tragfähige interne Arbeits- und Diskussionsfassung freigegeben werden. Die nächste Stufe sollte nicht eine komplette Neuentwicklung sein, sondern eine kontrollierte Abstimmungsrunde mit Robert Lange / salvevita, Prof. Frank Bier / IMDB und anschließend Michael Zänker / IKB.

Vorgeschlagene nächste Version nach Rückmeldungen: V6.3 - Abstimmungsfassung. Diese sollte nur Änderungen enthalten, die aus der fachlichen Abstimmung abgeleitet sind: Kürzung, Zusammenführung von Bogen B/D falls gewünscht, klinische Begriffsschärfung, digitale Pflichtfeld-/Sprunglogik und Datenschutztext.

8. Konkrete nächste Schritte

Nr.	Schritt	Ziel
1	Bogen B und D mit Robert Lange / salvevita durchgehen	Klärung: Standardmethode vs. Implementierbarkeit; App-/Plattformbezug; Länge der ärztlichen Befragung.
2	Bogen A und C mit Michael Zänker / IKB fachlich plausibilisieren	Klärung: klinische Symptome, Stratifizierungslogik, Patientengruppen, Studienzeitpunkt.
3	Mit Frank Bier die Projektlogik und Förderlogik abgleichen	Klärung: Erfüllt V6 das IMDB-Arbeitspaket? Welche Fassung wird dokumentiert / abgelegt?
4	Entscheiden, ob Bogen B und D getrennt bleiben	Bei langer Befragung: B/D-Kombiversion für Rheumanetzwerk erstellen.
5	Digitale Umsetzung vorbereiten	Formularlogik, Pflichtfelder, Sprunglogik, Datenexport, Datenschutz und Versionierung definieren.

9. Schlussbewertung

Das V6.2-Paket ist gegenüber V5.1 deutlich näher am tatsächlichen Projektauftrag. Der wichtigste Fortschritt ist die klare Trennung zwischen patientengerichteten Fragebögen und ärztlich/versorgungsstrukturellen Befragungen. Damit ist der rote Faden wieder korrekt: Bogen A und C betreffen Patient:innen; Bogen B und D betreffen Rheumanetzwerk, Ärzt:innen und Implementierung. Die QA empfiehlt, V6.2 als robuste Arbeitsgrundlage zu verwenden und nach Rückmeldungen gezielt eine V6.3-Abstimmungsfassung zu erstellen.